Registro entre pacientes y cierre

Finalidad y momento de uso

Registrar registro entre pacientes y cierre en el momento de la actividad correspondiente a ODO-LD12. No usar datos simulados ni declarar ejecución únicamente por disponer del formato.

Responsabilidad y preparación

La persona que realiza la actividad registra datos reales; el verificador revisa coherencia y evidencia según rol. Reunir instrucciones y soportes necesarios, confirmar identidad del objeto o usuario y usar acceso autorizado.

Fecha / hora / unidad

Registrar fecha y hora reales, periodo y secuencia cuando procede. No diligenciar retrospectivamente como si se hubiera realizado en otra fecha; las correcciones quedan trazables.

Actividad / producto

Identificar producto/indicador real, lote, vigencia y uso autorizado. Registrar preparación y criterio aplicado según etiqueta; no dejar recetas genéricas ni marcar conformidad sin verificar.

Resultado / hallazgo

Describir resultado real, desviación y medida concreta; asignar plazo y quién verificará eficacia. No cerrar únicamente porque se redactó un plan o se pidió una reparación.

Responsable / acción

Identificar persona y rol que ejecuta o verifica, no solamente cargo genérico. Asociar autenticación válida cuando la naturaleza del registro la exige y proteger permisos de acceso.

Formato para diligenciar

Documento asociado: ODO-LD12 | Registro en blanco. Adjuntar hojas adicionales identificadas si se requiere.

Fecha / hora / unidad	Actividad / producto	Resultado / hallazgo	Responsable / acción

Observaciones y soporte vinculado

_____

_____

_____

Criterios de revisión y custodia del registro

Preparación y selección

Identificar superficie/dispositivo, material, suciedad y nivel de riesgo. Leer etiqueta, ficha técnica y de seguridad; verificar uso autorizado, compatibilidad, concentración, vida útil y tiempo de contacto. Definir EPP, ventilación y elementos diferenciados por zona antes de iniciar.

Ejecución verificable

Delimitar área, retirar suciedad y residuos, limpiar y aplicar desinfectante compatible. Mantener contacto indicado, sin secado anticipado ni mezclas improvisadas. Para agua, succión, impresiones o residuos aplicar instrucciones particulares descritas en este documento; limpiar no equivale a esterilizar.

Contención de fallas

Ante producto no identificado, dilución incorrecta, derrame o superficie incompatible, detener y aislar área/material. Evaluar exposición y atención ocupacional cuando pertinente. Repetir proceso solo después de corregir causa y comprobar que material no quedó dañado o con residuo peligroso.

Registro no satisfactorio

Registrar la diferencia, proteger el área/usuario/material según riesgo y avisar al responsable. Establecer acción, plazo y comprobación posterior. En reprocesamiento una carga no conforme no se libera por urgencia de agenda.

Archivo y correcciones

Identificar fecha, autor, versión y ubicación de anexos. Corregir por adenda o registro trazable sin borrar original. Custodiar con reserva si contiene datos de salud y asociar autenticación legalmente válida donde corresponda. El diseño no incluye campos de firma.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Residuos

Resolución 591 de 2024, manual de gestión de residuos generados en atención en salud; Decreto 780 de 2016. Diagnóstico, ruta y soportes reales por sede.

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%20591%20de%202024.pdf